HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

# Aide-soignant à l'accueil – Analyse des pratiques

M. LAFI
*Urgentiste & Chef adjoint – Service des urgences*
G. SILVETTI
*Infirmier Référent – Service des urgences*
E. MARTIAL
*Cadre de santé – Service des Urgences*

*date*

**Pour cette formation, nous demandons à chaque professionnel de présenter une situation qui lui pose des problèmes dans sa pratique au quotidien.**

**Pour ce faire, nous vous demanderons d'en discuter ensemble et de former des binômes.**

**Chaque binôme choisira une situation qui entre dans l'un des thèmes suivants :**

**1 – Médico-Légal (PEC mineur, CNA, GAV, fugue, sortie, agressivité)**
**2 – Pathologies neurologiques**
**3 – Pathologies cardiologiques**
**4 – Pathologies respiratoires**
**5 – Pathologies psychiatriques**
**6 – Lien avec l'extérieur (transferts, brancardage, entrée/sortie)**
**7 - Réorientation**

**Pour chaque présentation, nous avons préparé trois diapositives qu'il vous suffira de remplir :**

**1 – La présentation de la situation**
**2 – La problématique et la solution que vous avez mises en place**
**3 – Les écrits**

**Le topo sera présenté au groupe lors de la formation et nous en débattrons ensemble.**

**Votre présentation doit durera 15 min : 5 min de présentation et 10 min d'échange**

**Votre présentation devra être envoyée quelques jours avant la formation.**
**Nous créditerons 2h de hors clinique sur vos Octimes (temps de préparation).**
**Vous pouvez solliciter à tout moment l'aide ou les conseils de l'équipe d'encadrement (Mehdi, Giovanni où Ericka).**

**Nous vous remercions pour votre engagement**

# LA SITUATION

- Présentation succincte de la situation :
  - Contexte
  - Localisation (IOA 1, 2 ou 3 ; Salle d'attente ; Accueil administratif ; ect)
  - Heure
  - Période : Jour / Nuit
  - Motif de consultation du patient
  - …

# LA PROBLEMATIQUE

- Qu’est-ce qui vous a posé problème ?
- Qu’est-ce que vous avez mis en place ?
- Comment avez-vous pris en charge le patient ?
- Avez-vous mobilisé des ressources humaines, organisationnels, institutionnels, …

 Ne pas confondre problème individuel avec une problématique globale.

# LES ECRITS

- Quels sont les protocoles / procédures du service ou de l'hôpital que vous avez à votre disposition en lien avec la PEC ?
- Existe-t-il des études ? Des écrits ? Des recommandations ? …
- Il y a-t-il un cadre législatif ? Si oui, lequel ?

# Situation n°1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

# LA SITUATION

- Présentation succincte de la situation
  - Patient schizophrène arrivé aves police et pompiers
- Localisation :
  - IAO 1
- Heure :
  - entre 1h et 3h du matin
- Période Jour ou Nuit :
  - Nuit
- Motif :
  - Patient en rupture de TTT virulent et très agressif





# LA PROBLEMATIQUE

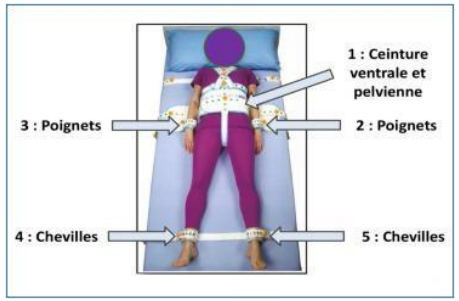
1

Manque d'un brancard a contention déjà monté car plusieurs patients déjà contentionnés.










2

Maîtrise du patient, montage rapide du brancard a contention, contention physique(as, ide) et chimique(ide) du patient

3

Soignants, Pompiers, Police et Agent de sécurité mobilisées.







# LES ECRITS

- **Quels sont les protocoles / Procédures du service ou de l'hôpital que vous avez à votre disposition en lien avec la PEC ?**
  - Essayez d'amener la personne vers des soins.
  - Si elle tient des propos délirants, ne pas la contredire, mais s'attacher à la rassurer. Et ensuite tenter de le convaincre de voir très rapidement un psychiatre. (cf pdf.).,
    - S.A.U. Hôpital Saint-Joseph |GHU Paris psychiatrie C neurosciences
    - Quand et comment hospitaliser mon proche schizophrène ?
- **Existe – t –il des études ? Des écrits ? Des Recommandations ?**
  - https://urgences-lecongres.org/wp-content/uploads/2022/06/ams29.pdf (cf PJ)
  - https://www.travail-et-securite.fr/ts/846/DOS/TS846P012025/face-a-la-violence-l-esquive-est-tout-un-art.html https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/la-violence-a-l-hopital-9782757307687/ **Prévenir, désamorcer, affronter de Michel** est psychosociologue, maître de conférence
- **Il y a un cadre législatif ?**
  - Oui plusieurs et de sources différentes :
    - Droits et responsabilités des personnes - Hôpital Paris Saint Joseph.
    - S.A.U. Hôpital Saint-Joseph |GHU Paris psychiatrie C neurosciences

# Situation n°2

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

# LA SITUATION

- Patient d’une cinquantaine d’années , avec un gabarit très imposant , et anciens boxeurs emmener par la police pour ébriété sur la voix publique , agitation et agressivité.

# LA PROBLEMATIQUE

- **Problématique :**

*A l'arriver dans le service , le patient est calme et coopérant, IDE d'accueil demandent à la police de partir et ceux lui dise de rappeler le 17 en cas de nécessite.*

*A l'IOA , l'interrogatoire ce passe bien jusqu'à ce que l'ide lui demander de ce déshabiller pour la suite de la prise en charge, le patient refuse et veut récupéré ses vêtements pour rentré chez lui .*

*Devant son refus de se soumettre aux règles de prise en charge , nous avons appelé l'agent de sûreté, les collègues en zone 2 , l'ide a rappelé la police en essayant plusieurs numéros , plus de 40 minutes se écouler avant de les avoir au bout du file , entre temps le patient a commencé à être agressif tans verbalement , que physiquement , 1 soignant a été toucher physiquement et l'agent de sûreté.*

*Accident de travail pour les deux collègues toucher de plusieurs semaines .*

- **Solutions mises en place :**
  - À l'arrivée de la police ,le patient a voulu agresser la police , il a été métriser et menotté , ensuite emmener en garde vu .
  - Appel des collègues en zone 2 Appel de l'agent de sécurité Appel de la police
  - Appel de la cadre de garde EFI fait ce même jour
  - Un Dépôt de plainte fait au commissariat par les deux collègues toucher physiquement par ce patient

# LES ECRITS

- Un EFI ( événement Indésirable fais ce jours )
- Dépôt de plainte au commissariat
- Traçabilités dans le dossier patient faite
- Possible interdiction d'être soigné à l'hôpital

**PROCEDURES :**

- Prise en charge d'un patient mineur zone 1 /2
  - Pour la prise en charge d'un patient mineur
    - le parents doit remplir l'autorisation de soin
    - le mineur doit être accompagné un des parents
    - Le parent doit être avec le patient durant toute la prise dans le service
    - Le patient doit être isolé dans un box de consultation sauf cas échéant et en zone 1 box 7
    - Le patient ne pourra sortir qu'en présence d'adultes majeur ( parents , frère )

# LES ECRITS

**PROCEDURES (SUITE)**

- Fugue
  - En cas de fugue ou sortie à l'insu du service
    - Celui qui constate la fugue soit prévenu l'IDE
    - Prévenir le médecin
    - Prévenir l'agent de sûreté
    - Le médecin préviens administrateur de garde, la police en fonction de l'état du patient , une
    - Alerte fugue est déclencher et en fonction des heures l'alerte passe un niveau au dessus
- Agression
  - En cas d'agression d'un membre du personnel par un patient :
    - le médecin est prévenu
    - Les cadres de santé ou IDE référent sont prévenu
    - L'agent de sûreté est appeler
    - En fonction de la situation la police est appeler
    - Interdiction d'inscrire le patient pour une prochaine venu , sauf urgence vital

En conclusion documentation sur ensemble, liens utiles protocoles

# Situation n°3

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

# LA SITUATION

- Présentation succincte de la situation
  - Contexte : Patient psy qui fugue
- Localisation :
  - Zone 2
- Heure :
  - Entre 20h et 00h30 Période Jour ou Nuit : Nuit
- Motif :
  - Hallucinations/peur d'être agressé

# LA PROBLEMATIQUE

- **Problématique :**
  - Le Rush entre 20h et 00h30, accompagnant autorisé avec le patient psy, agent de sécurité devant gérer ce patient et la zone (sas pompiers, zone 2 etc.,
  - soignants devant gérer le flux et les autres patients.
  - Constatation de la fugue du patient, appel agent de sécurité, chercher le patient dans les urgences, patient qui a fugué avec son accompagnant
  - Vestiaire / coffre, demander au patient de retourner dans son box, le ramener dans le box, surveillance +++
  - Agent de sécurité mobilisé, soignant mobilisés pour cherche le patient
  - déclaration de fugue par le médecin réfèrent de la PEC
  - appel des cadres de nuit et de l'administrateur de garde, appel du commissariat du 14e arrondissement
- **Solutions mises en place :**
  - Des pyjamas roses ont été obligatoires a faire mettre par les patients des l'IAO avant et pendant les contentions.
  - Tous les vêtements ont été places dans des sacs transparents.
  - Déclaration de fugue, appel agent de sécurité, commissariat du 14ème prévenu de la fugue, patient en tenue rose pour que les autres services nous appellent et que les patients soit plus facilement repérable et rapidement : (Fugue / Sortie à l'insu du service (Cf P.J))
  - Déclare la fugue auprès du médecin senior référent de la PEC, le médecin prévient le commissariat de la fugue du patient.

# LES ECRITS

- Existe – t –il des études ? Des écrits ? Des Recommandations ?.
  - Patient fugueur dans un service, que faire ? – MACSF selon le Germain Decroix, Juriste a édité le 4 septembre 2024. Chapitre IV. La fugue, une question clinique | Cairn.info, Lieu d'asile, Manifeste pour une autre psychiatrie. Par Thierry Najman, Psychatre (75) - Hors collection / 2015 / Odile Jacob
  - Sémiologie des conduites de fugues - EM consulte EMC psychiatrie du professeur. Écris par : Bernard Lafont : Médecin en chef, professeur agrégé du Val-de-Grâce, Clinique de psychiatrie, hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, 74, Dominique Vallet : Médecin en chef, spécialiste des hôpitaux des Armées Michel Plouznikoff : Médecin en chef, spécialiste des hôpitaux des Armées

- Il y a un cadre législatif ?
  - Oui plusieurs et de sources différentes :
    - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196142/
    - Droits et responsabilités des personnes - Hôpital Paris Saint Joseph
    - Microsoft Word - RM2011-071P_tome1FLcommunicable.doc P 46 chap 1.2.4
    - Fiche-sortie-a-linsu-du-service.pdf (Voir en PJ)
    - dgos_onvs_fiche_39.pdf
    - Fugue d'un patient : quelle responsabilité pour les infirmières ? – Actusoins
    - Isolement et Contention en psychiatrie générale - Recommandations

# Situation n°4

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

# LA SITUATION

- Lors de mon poste à l'IOA (Accueil et Orientation des Urgences), j'ai été confrontée à une situation complexe concernant un patient en détresse psychiatrique. Il s'est présenté spontanément, visiblement agité, tenant des propos incohérents et présentant des signes d'anxiété et de désorganisation.
- En m'approchant avec l'infirmière pour recueillir des informations, le patient s'est rapidement énervé. Il a crié, menacé le personnel et a lancé une chaise. Il refusait tout soin et devenait de plus en plus agressif, mettant en danger sa sécurité ainsi que celle des autres patients et de l'équipe soignante.

# LA PROBLEMATIQUE

- **Problématique :**
- *Comment, en tant qu'aide-soignante à l'IOA, assurer la sécurité de tous face à un patient en crise psychiatrique violente refusant les soins, tout en respectant son intégrité, ses droits, et le cadre légal ?*
- **Solutions mises en place :**
- 1. Isolement du patient
  - Le patient a été installé dans une salle d'examen sécurisée, sans objets dangereux, afin de limiter les risques pour lui-même et pour l'équipe. Cela a également permis d'apaiser la tension dans la zone d'attente.
- 2. Posture professionnelle et communication adaptée
  - Je suis restée calme, posée et rassurante dans ma communication, sans confrontation. J'ai gardé mes distances tout en restant présente, en veillant à sa sécurité et en tentant de le rassurer.
- 3. Travail en équipe
  - Nous avons immédiatement alerté le médecin, l'IDE et l'agent de sécurité. L'équipe psychiatrique a été appelée pour une évaluation rapide. Une contention a été mise en place à la demande du médecin, en respectant le protocole (fiche de suivi, surveillance régulière).
- 4. Respect des procédures
  - Les règles concernant la contention ont été rigoureusement respectées : justification médicale, surveillance continue, limitation dans le temps et traçabilité. Le patient a ensuite été pris en charge par l'équipe psychiatrique pour une évaluation plus approfondie et une éventuelle hospitalisation.

# LES ECRITS

- Traçabilité dans le dossier de soins :
  - Description précise du comportement du patient.
  - Mise en place de la contention avec heure de début et de fin.
  - Surveillance effectuée et évolution de l'état du patient.
  - Appel à l'équipe psychiatrique et suite de la prise en charge.
- Fiches spécifiques :
  - Fiche de contention remplie selon les protocoles.
  - Fiche d'évènement indésirable renseignée.
- Transmissions orales et écrites :
  - Informations transmises à l'équipe suivante.
  - Transmission au cadre de santé pour suivi et signalement.

# CONCLUSION PERSONELLE

- Cette situation m'a permis de prendre conscience de l'importance de la gestion du comportement agressif en milieu hospitalier, surtout en lien avec la psychiatrie. En tant qu'aide-soignante, notre rôle ne se limite pas à l'aide aux soins techniques, mais implique aussi une posture humaine, d'écoute, de vigilance et de réactivité face à l'imprévu. Le travail en équipe et le respect du cadre légal sont essentiels pour protéger tous les acteurs du soin.

# Merci

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue